

إِسْمُ الْمَرِيضِ رِبَاعِيًّا : نَجِيهٌ عَلَى السَّيِّدِ بَدْرَانِ

المحافظة : الشرقيه

الحى / المدينة : بلبيس

العنوان : //

رقم البطاقة : 25709301301328 رقم التليفون : 01006135750

تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 30-09-1957 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

المقرر بما فيه

التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

GR I-E

جورستان افغانستان
روستا پیلانی
لیدی حساب
موسسین رمضان
صحة الحسابات المرفعة
للجنة و مدير

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- /d ----- /d ----- /d.l ----- /d.l

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نفقات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشئون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نجيه على السيد بدران National ID: 25709301301328	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name	: الأستاذة / نجية - علي السيد ودان	Request No.	: 13006808
Patient No.	: 25709301301326	Request Date	: 24/02/2022
Path No.	: 533/2022	Verification Date	: 08/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 64 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast mass. Post neoadjuvant chemotherapy.

History of the specimen:

Right mastectomy & axillary clearance.

Gross Examination:

Right breast: 19x17x6 cm, with skin covering, 26x19 cm. Nipple was unremarkable. Axilla: 3x3 cm. Cut section revealed UOQ ill defined firm grayish white tumor nod site: 3.5x2x1.5 cm, submitted 1.5 cm away from deep margin and 3cm away from skin. Axillary fat dissection revealed 14 nodules. Largest measured 2x2 cm in diameter.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II
- Angiolymphatic invasion: Positive.
- Ductal carcinoma in situ: No.
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in 2/13 nodes with extracapsular extension.
- Resection Margins: Free.
- Histologic response to therapy: Partial Pathological response.

Diagnosis:

Right mastectomy & axillary clearance:

Invasive duct carcinoma, GII

Partial Pathological response. 35% Tumor necrosis index.

Positive lymphovascular emboli.

Negative perineural invasion.

Verified by :

Dr. Marwa mahmoud

Printing Date : 08/03/2022 09:42:50

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

1-CHEST

- Multiple irregular spiculated heterogeneously enhancing mass lesions altered seen scattered within right breast associated with diffuse parenchymal distortion with the largest mass is seen measuring about 2.3x 4.4 cm.
- Multiple pathologically enlarged right axillary (level I and II) lymph nodes measuring up to 1.5x 1.7 cm.
- Right lower lobe apical segment subpleural pulmonary branching micro-nodule is seen likely inflammatory.
- Middle lobar thick atelectatic band.
- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Enlarged right thyroid lobe harboring few hypodense subcentimetric nodules.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- Mildly enlarged liver with homogeneous CT texture. No focal lesions or intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Right renal lower calyceal dense stone is seen measuring 4 mm with no related back pressure changes.
- A 3 cm right renal cortical cyst is also noted.
- Left adrenal gland subcentimetric (7.5 mm) fat containing lesion is seen likely myelolipoma.
- Normal appearance of the pancreas, spleen, left kidney, right adrenal, aorta, I.V.C and the pelvic organs.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The revised bone window revealed:
 1. No CT evidence of vertebral collapse or extra-osseous soft tissue component.
 2. Dorsolumbar spondylosis.

OPINION:

- Right breast masses with ipsilateral axillary lymphadenopathy.
- Right lower lobe apical segment subpleural pulmonary branching micro-nodule likely inflammatory.
- No definite hepatic or osseous metastatic deposits.

Reported By,

Dr. Amr Farouk, MD
Dr. Ghassan Hamed Khalifa, MSc

03-Oct-2021 03:12 PM



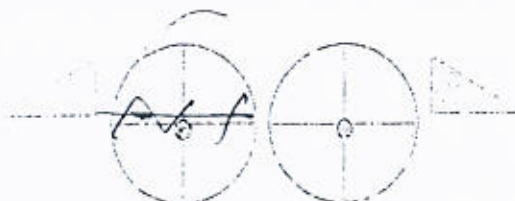
الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة العامة



MDT FORM

10.3.22

Name	فنية على السيد
Age	٤٣
MRN	٤٠٧٩٢٠١٢٠١٣
ID	٤٠٧٩٢٠١٢٠١٣
Phone	٤٠٧٩٢٠١٢٠١٣
Community	١٠٠٦١٢٥٧٥



T N M

Clinical Data

INDC

8/8
5/8
+ve

Rt breast Cancer, post NACT,
post Rt MRM

Invasive ductal Carcinoma
partial pathological responses

35 % of tumour MDT OUTCOME & PLAN

L.Ns 2/13 C partial pathologic Resp

YPT₂ YPN₁

- For. PORT

- 1 Kadyla. P. 14 cycles

AI 154

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Amell

10.3.22

10.3.22

10.3.22